جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : رشا عطيه كامل ابو العزم
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اوسيم **العنوان :** ****
رقم البطاقة : 28402012111726 **رقم التليفون :** 01550904944 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-02-1984 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: رشا عطيه كامل ابو العزم
National ID: 28402012111726

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

06/10/2026

MDT FORM

Name:	Rasha Attia Kaml ////////	**MRN:**	5823
Age:	42 Y	**ID:**	28402012111726
Menopausal Status:	post	**Phone:**	01550904944
NRS SCORE:		**Marital Status:**	M
BMI:		**Family History:**	Free
CO Morbidity:	Med Free	**Reason Of MDT:**	Post Op Lt MRM

Clinical Data:

BX: No residual tumor

ER 3/8 **PR** 3/8 **HER** +3 **KI67**

Sonomammography:
No DCIS, Free NAC, free margins, 0/11 LNs (one

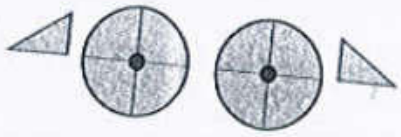
Mets Workup:
ypT0,N0(i+)

History:

Recommendations:
For post Op MDT

MDT Outcome & Plan
cT4bN+ --> NACT TCHP then Rt MRM pCR
for adj PHESGO (complete 1y)
PORT CW +PCN
ET AI 5y (confirm Menopausal levels by E2,FSH and add Zoladex accordingly)

R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]





DMS

٤٤٠٤٦١٤/٤٤

* علاج تزعيم

* قرار بعلاج

Name: رشا عطيه كامل **MR. :** 5823	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with left breast cancer, clinical stage T4 N1 M0, estrogen receptor 3/8, progesterone receptor 3/8, HER2 3+. The pathology showed grade 2 invasive ductal carcinoma with a grade 3 hypersensitivity reaction during carboplatin administration for cycle 2 of a regimen that included Taxotere 135 mg and carboplatin, followed by neoadjuvant PHESGO.

On examination, left breast edema had decreased and there was no left axillary lymph node reaction after carboplatin. Serum albumin decreased to 1.78 g/dL. Neck ultrasound continued to show a right thyroid nodule measuring 11 × 9 mm, classified as TIRADS 4, with follow-up planned. The patient completed cycle 3 of Taxotere 135 mg, carboplatin AUC 5, and PHESGO.

The patient's ejection fraction was 10/12 (69%) while receiving neoadjuvant TCHP. Cycle 4 of the regimen included Taxotere 135 mg, carboplatin AUC 5, and PHESGO. Laboratory studies were acceptable for prophylactic filgrastim (Neupogen).

Neoadjuvant TCHP continued with cycle 5. Neck ultrasound performed in February 2026 demonstrated a prominent right parotid gland and solid thyroid nodules classified as TIRADS IV.

The patient reported oral mucositis and gastrointestinal irritation during cycle 6 of PHESGO and received supportive treatment; an echocardiogram was ordered before the next visit.

On 7 May 2026, pathology from left modified radical mastectomy (MRM) showed invasive ductal carcinoma grade 2, ER 3/8, PR 3/8, HER2 3+, with 7 of 5 (likely a typographical error) high-power fields positive, and 6 tumor cells. Isolated tumor cells were identified in one of eleven lymph nodes (i+). The case was pending multidisciplinary team discussion, and the patient was scheduled for cycle 8 of PHESGO.

The same findings were reiterated, confirming the left breast cancer characteristics, surgical pathology, and pending MDT review, with the patient slated for cycle 8 of PHESGO.

A port insertion was pending in preparation for Zoladex and Femara, with the patient planned to receive cycle 10 of PHESGO as adjuvant therapy; the ejection fraction was recorded at 63% on 28 April 2026.

The patient received cycle 11 of PHESGO, continued Femara, and supportive treatment; an echocardiogram on 12 August 2026 showed an ejection fraction of 65%. Plans were made for cycles 12 and 13, with pharmacy coordination.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	الوقت :	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

The patient reports not having received the port yet.

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنت المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 9/12/2025 G

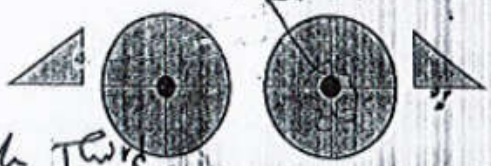
Name	رشا عطية كامل ابو الدهب	MRN	3197 / C.Co
		ID	
Age	41 yr.	Phone	01550904944
Menopausal status	Regular.	Marital status	M
NRS SCORE		Family history	-ve
BMI		REASON OF MDT	New Case
CO morbidity	M → Free. S → Free C-S, bil myomectomy.		

Clinical Data

Left breast.

BX: IDC, G3, ER/PR Strong +ve, HER2 +ve (+3), Ki67 RDCIS. Skin edem & Middle retroareolar. L

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
3/8	3/8	+ve (+3)	



Sonomammography: ACR B,
→ Left breast irregular mass with middle third of grouped microcalcification,

Mets Workup:
→ Skin thickening and edema.
→ longest mass at 12 o'clock about 4Cm from nipple, measuring 1.6 x 2 Cm.

TNM 4b 1 o

N.B. Pt is refusing Photography.

Recommendations:
→ Another mass at 10 o'clock (6 x 9 mm)
→ Few lesion at 2-3 o'clock.
→ multiple Bx left axilla LNs.
CT CAP → Thyroid nodules → Neck U/S required.
Bone Scan → Free

MDT OUTCOME & PLAN

① Rx TCHP x 6 cycles. For possible Neo adj then left MRM

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / رشا عطيه كامل ابوالعزم	Request No.	: 13001590
Patient No.	: 28402012111726	Request Date	: 05/11/2025
Path No.	: SR-1562/25	Verification Date	: 17/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 41 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast 12 o'clock mass, BIRADs 5.
Nature of Specimen: Referred block & slides (Tru-cut biopsy).

Gross Examination:
One referred block labelled by (204686-25). Together with, three referred immunostained slides for (ER, PR & HER2neu).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).
* DCIS: Focal high grade ductal carcinoma insitu (Solid pattern with comedo type necrosis).
* Angioinvasion: Absent.
* Perineural invasion: Absent.
* Necrosis: Focal.
* Microcalcification: Present.

* IPT:
- ER: Weak nuclear staining in 5% of tumor cells (score 3/8).
- PR: Weak nuclear staining in 5% of tumor cells (score 3/8).
- Her2: Strong complete membrane staining in more than 10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:
Left breast mass, Referred block & slides (Tru-cut biopsy):
- Invasive duct carcinoma, Grade 3.
- Focal high grade ductal carcinoma insitu (Solid pattern with comedo type necrosis).
IPT:
- ER: Positive (score 3/8).
- PR: Positive (score 3/8).

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنك المصري لتنمية الصادرات

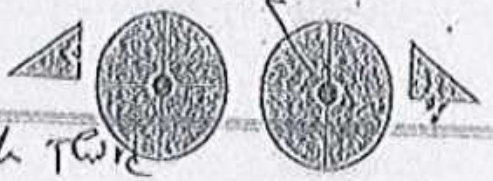
MDT FORM 9/12/2025 G.

Name	رشا مصطفى كامل ابراهيم	MRN	٣١٩٦/C.Co
Age	41 yr.	ID	
Menopausal status	Regular.	Phone	01550904944
NRS SCORE		Marital status	M
BMI		Family history	-Ve
CO morbidity	M → She. S → Free C.S, Bl myasthenia.	REASON OF MDT	New Case

Clinical Data

BX: IDC, G3, ↑ Lymphovascular invasion, DCIS. Skin edema & Nipple retraction.

ER: 3/8 | PR: 3/8 | HER 2: +Ve (+3) | KI67:



Sonomammography: ACR B,
Left breast irregular mass with middle TCZ of grouped micro-calcifications,

Mets Workup:
→ Skin thickening and edema.
→ Largest mass at 12 o'clock, about 4cm (1.6 x 2 cm).

TNM
4b 1c

4Cm Pronounable,
N.B. Pt is refusing Photography.

Recommendations:
→ Another mass at 10 o'clock (6 x 3mm).
→ Few lesions of 2-3 o'clock.
→ multiple Enlarged left axillary L.N.
→ CT CAP → Thyroid nodules → Neck U/S required.
→ Bone SCan → Free

MDT OUTCOME & PLAN

① 6m TCHP x 6 cycles. Then Surgery
② Then left MRM

For possible Neo adj then

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	:الاسم / ريتا عطيه كامل ابوالفرج		
Patient No.	:28402012111726	Request No.	:13001590
Path No.	:SR-1562/25	Request Date	:05/11/2025
Sex	:Female	Verification Date	:17/11/2025
Age	:41 Y	Financial Category	:جوستاف روسي - فئة اولى
Referreing Doc :		Department	:Out Patient
		Registered by	:Mrs.Meyada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast 12 o'clock mass, BIRADs 6.
Nature of Specimen: Referred block & slides (Tru-cut biopsy).

Gross Examination:
One referred block labelled by (204686-25). Together with, three referred immunostained slides for (ER, PR & HER2neu).

Microscopic Examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).
- DCIS: Focal high grade ductal carcinoma insitu (Solid pattern with comedo type necrosis).
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Necrosis: Focal.
- Microcalcification: Present.

- IPT:
- ER: Weak nuclear staining in 5% of tumor cells (score 3/8).
- PR: Weak nuclear staining in 5% of tumor cells (score 3/8).
- Her2: Strong complete membrane staining in more than 10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:
Left breast mass, Referred block & slides (Tru-cut biopsy):
- Invasive duct carcinoma, Grade 3.
- Focal high grade ductal carcinoma insitu (Solid pattern with comedo type necrosis).

IPT:
- ER: Positive (score 3/8).
- PR: Positive (score 3/8).

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY

Patient Name	: الآنسة / ريما عطيه كامل الوكيل		
Patient No.	: 28402012111726	Request No.	: 13001590
Path No.	: SR-1562/25	Request Date	: 05/11/2025
Sex	: Female	Verification Date	: 17/11/2025
Age	: 41 Y	Financial Category	: جوستاف روسي - فئة الدرجة
Referring Doc	:	Department	: Out Patient
		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Her2: Positive (score 3+).

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within ≤ 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghonaim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]



Dms
فيسجو



National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

06/10/2026

MDT FORM

Name:	Rasha Attia Kamil //////	**MRN:**	5823
Age:	42 Y	**ID:**	28402012111726
Menopausal Sta	post	**Phone:**	01550904946
NRS SCORE:		**Marital Status:**	M
BMI:		**Family History:**	Free
CO Morbidity:	Med Free	**Reason Of MDT:**	Post Op Lt MRM

Clinical Data:

BX: No residual tumor

ER: 3/8 **PR:** 3/8 **HER2:** +3 **KI67:**

Sonomammography:
No DCIS, Free NAC, free margins, 0/11 LNs (one node: isolated tumour cells)

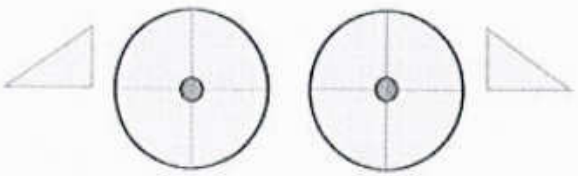
Mets Workup:
ypT0,N0(i+)

History:

Recommendations:
For post Op MDT

MDT Outcome & Plan
cT4bN+ --> NACT TCHP then R: MRM pCR
for adj PHESGO (complete 1y)
PORT CW +PCN
ET AI 5y (confirm Menopausal levels by E2,FSH and add Zoladex accordingly)
Zometa /6m for 2y

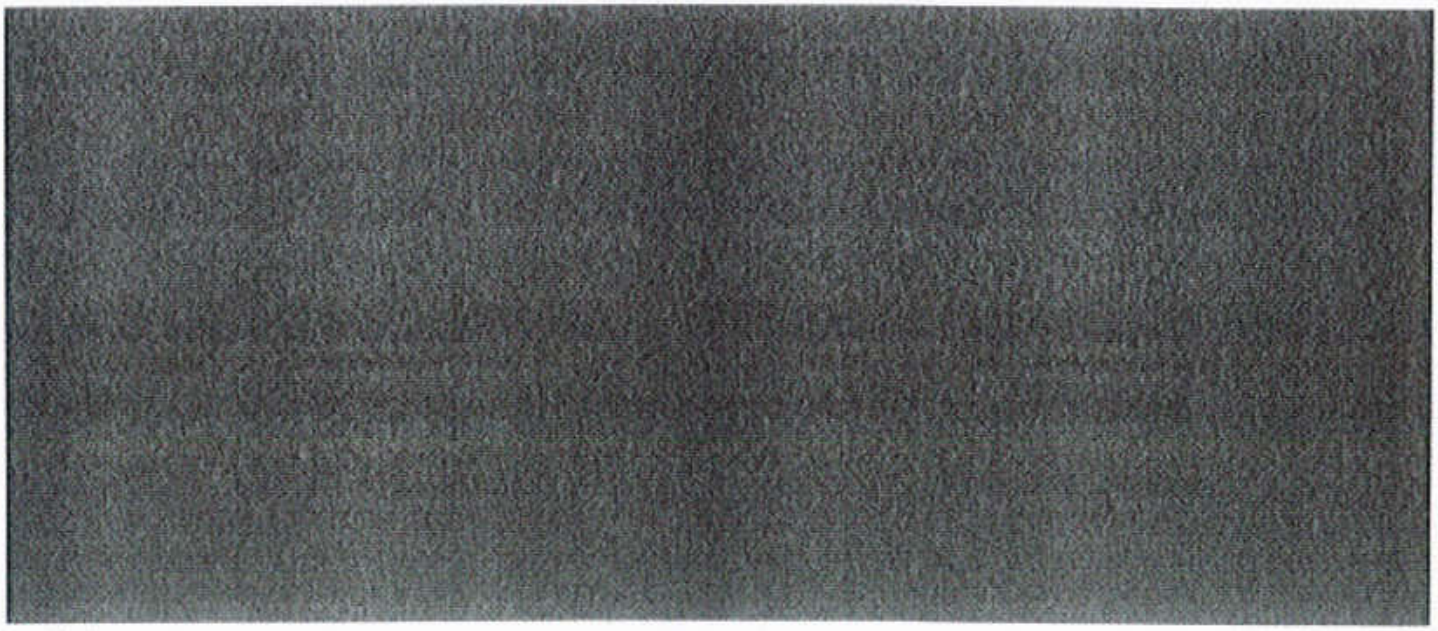
R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ نادر هس					



MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / رشا عطيه كامل ابوالعزم	Request No.	: 13006378
Patient No.	: 28402012111726	Request Date	: 07/05/2026
Path No.	: 1386/26	Verification Date	: 24/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer post NACT .
Nature of the specimen: Left breast & Left axilla (MRM), (Post NACT)

Gross Examination:
- Procedure: Left MRM

measured 25x15x5 cm with covering skin ellipse measured 16x10cm .
- Tumor extent : A greyish white tumour bed site
- Size: 5 x4 x3 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 1.5 cm away from deep margin
- Axilla : Fibrofatty tissue piece measured 6x5x2 cm entangling 11 nodules up to 2x1 cm

Block designation :
1:5 TBS
6.Nipple
7.Deep margin
8.,9,10,11 ALNDs
Grossing dione by Dr.Heba El-Shafeey

Microscopic examination:
- Histological type: No residual tumor
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Lymphovascular emboli: Free
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free eleven L.Ns out of eleven (0/11) with none node showed isolated tumor cells.
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / رشا عطيه كامل ابوالعزم	Request No.	: 13006378
Patient No.	: 28402012111726	Request Date	: 07/05/2026
Path No.	: 1386/26	Verification Date	: 24/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Diagnosis:
Left MRM (post NACT) :
-No residual tumor
- Margins :Free deep margin.
- Nipple &areola: Free nipple and areola
- Lymph nodes: Free eleven L.Ns out of eleven with one node showing isolated tumor cells (0/11)
- Pathological response to therapy :Pathologic partial response
- Stage : ypT0 , ypN0(i+)

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim
Dr.Heba Hassan Adly

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE1D_FRONT_BACK]]

رقم التقرير : ٧٨٢

مستشفيات جامعة القاهرة
إدارة الخدمات الاجتماعية
مركز قصر العيني لعلاج الأورام
والطب النووي

تقرير طبي بالخدمات الاجتماعية الطبية

اسم المريض : رشا عطية كامل السن : ٤٤ المهنة : القسم : ٧٨٢

رقم المستشفى : تاريخ الدخول / / ٢٠ تاريخ الخروج / / ٢٠

مازال تحت العلاج

التشخيص : المريضة تعاني من ورم عين اليسرى الأيمن Hbraterge وقد تلقت Tetp وما قبل إلى لفترة تعاني على إثرها الكلى اليسرى الأيمن وقد تلقت العلاج الإشعاعي وأيضا الغدة بإيضا يوم ٢٠٠٦/٩٦٧ وبهاية يوم ٢٠٠٦/٩/٢٧

التوصيات :

مشرفة القسم

الطبيب المعالج

تحريرا في ٢٠٠٦/٩/٢٧

السيد الأستاذ / مدير مستشفى [illegible]

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم التقرير الطبي للمريض المذكور .

برجاء التكرم باتخاذ اللازم نحو مساعدته دون أدنى مسئولية على المستشفى .

الاخصائي الإجتماعي

مدير الخدمة الإجتماعية

المدير

٢٠٠٦/٩/٢٧